

EUGÊNIO DANIEL FILHO

NS 2229218711M DN 981

EUGENIO		Profissão - ADM.
SINTOMAS/ QUEIXA	Romo alto / Acorda muitas x a noite / Boca seca	
MEDICAMENTOS	não usa medicamento.	
Rinite / Sinusite / Apnéia /		
HORA QUE DORME:	22:30	HORA QUE ACORDA: 6/7hs
BANHEIRO	2 à 3x	(câncer de próstata há 5a).
TIPO DE RESPIRAÇÃO	Basal	Dra. Thalita
EXERCICIO FISICO	compete Voley / Hidroquático	Patrícia
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (20:30)		
PESO: 83	ALTURA: 183	IAH: 6,18 MALLAMPATI: SPO2:
15/05/23 Adaptação do CPAP		
P = 5,0 - 15,0 cmH ₂ O		
APE = 1 rampa		
22/05/23 P = 8,1 cmH ₂ O (1x p/ ir banheiro)		
m. de uso: 7h52'		
IAH = 6,7 e/ev ajuste máscara.		
Fuga = 1,3, 2 l/min. fuc		
29/05/23 P = 7,0 Bem adaptado.		
IAH = 1,7 ATM a (D) esta deslocada.		
m. de uso: 7h59'		
Fuga = 14,4 — 35. fuc		
19/06/23 P = 8,0 cmH ₂ O Bem adaptado, s/ queixas. / cansaço melhorou.		
IAH = 1,7 e/ev fuc		
Fuga = 10,2 l/min		
m. de uso: 7h50		
10/07/23 P = 8,0 cmH ₂ O		
IAH = 2,3 e/ev Melhora do cansaço		
Fuga = 10,3 l/min 1x ao banheiro		
m. de uso: 7h43' fuc		
11/08/23 P = 8,0 cmH ₂ O Bem adaptado		
IAH = 1,9 e/ev fuc		
m. de uso: 7h33'		
Fuga = 1,9		
22/09/23 P = 8 cmH ₂ O - pouco mais escape em selmbus		
IAH = 2,4 e/ev - Bem adaptado / duplo.		
m. de uso =		
Fuga = 23 l/min		
27/10/23 P = 8 cmH ₂ O 2x acorda		
IAH = 1,4 e/ev Orienta que verifique o travessão.		
m. de uso: 7h20' fuc		
Bem adaptado		

12/01
2024 P=8cmH₂O
IAH = 1,4 e/h
m de uso: 7h30'
fuga: 4,2 l/min

Bem adaptado
usa micropore

vai viajar azeite - não vai levar
capô

Eugenio

04/08/25

20/03/24 P=8cmH₂O
IAH = 1,0 e/h
m de uso: 6h35'
fuga: 25,2

Bem adaptado
Oriento uso micropore
Natacha

20/05
24 P=8cmH₂O
IAH = 1,3 e/h
m de uso: 6h18m
fuga: 15,6 l/min

Bem adaptada
não utiliza nos viagens

Natacha

15/07
24 P=8cmH₂O
IAH = 1,3 e/h
m. de uso: 7h30'
Fuga = 15,1

ajustar masc.

Jua Cláudio

20/09/24 P=8cmH₂O
IAH = 1,9 e/h
m de uso: 5h51'
fuga: 15,8 l/min

Bem adaptado
Oriento ajuste de
mascara

Natacha

08/10
24 P=8cmH₂O
IAH = 1,9 e/h
m. de uso: 6h

↓ P=77Kg
Bem adapt. solicita ajuste masc.
Jua.

10/02
25 P=8cmH₂O
IAH = 0,9 e/h
m. de uso: 6h25'
fuga = 20 l/min.

(27/30d.) (troco masc. e
tranqueia.)
4d < 4hr
Jua Cláudio.

12/05
25 P=8cmH₂O
IAH = 0,8 e/h
M. de uso: 5h51'
fuga = 14,0 l/min.

- Bem adapt., s/ queixas.
- Viajou e levou
- Oriento o uso

Jua

07/07
25 P=8cmH₂O
IAH = 1,2 e/h
m de uso: 5h17'
fuga: 33,4 l/min

7 dias < 4hs

Bem adaptado

Natacha

Eugênio Daniel Filho

04/08/25 / P = 8cm H₂O

Boca seca;

IAH = 1.3 e H₂O

m. de uso: 6h40'

Fuga = 14 e pm

Paciente...: 21668615 EUGENIO DANIEL FILHO

Nascimento.: 02/04/1954 Sexo:M

Pedido: 63562909

RG.: 65701094 SSP SP

CPF.: 73850667804

Convênio...: HAPVIDA MATRIZ

Matrícula...: 3010F019796005010

Solicitante: Dr(a) PATRICIA DANIELA OY

Exame:

TC DE SEIOS DA FACE

Dt Realização: Dt Liberação:

30/03/23 16:58 30/03/23 18:02

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS DA FACE

Indicação Clínica: Avaliação.

Técnica de Exame : Aquisição volumétrica, em aparelho multislice, com posteriores reconstruções multiplanares.

RELATÓRIO

- Textura óssea normal.
- Espessamento mucoso lobulado no assoalho dos seios maxilares e esfenoidal à esquerda, podendo corresponder a pólipos/cistos de retenção.
- Espessamento mucoso concêntrico nos recessos fronto-etmoidais.
- Formação hipodensa, de aspecto polipóide, com contornos regulares, se insinuando pelo meato nasal médio esquerdo até a nasofaringe.
- Discreto material hipodenso ocupando algumas células etmoidais anteriores.
- Cornetos de contornos e dimensões normais.
- Septo nasal sinuoso, associado a esporão ósseo que comprime a concha nasal inferior direita.
- Fossas pterigopalatinas e espaço parafaríngeo de aspecto anatômico.
- Glândulas oculares, nervos ópticos, musculatura extrínseca, gordura intra e extra-conal sem alterações apreciáveis ao método.

- Sinusopatia, conforme acima descrito.

- Formação hipodensa, de aspecto polipóide, com contornos regulares, se insinuando pelo meato nasal médio esquerdo até a nasofaringe.

- Septo nasal sinuoso, associado a esporão ósseo que comprime a concha nasal inferior direita.

Esse é um exame complementar, e como tal, deve ser analisado pelo médico assistente para correlação clínica e decisão terapêutica.



DIEGO FLORIANO MACIEL - CRM 150146-SP

Nome: EUGENIO DANIEL FILHO

Data de Nascimento: 2-4-1954

IMC: 25,08

Sexo: Masculino

Data do exame: 04-04-2023

Peso: 84 kg

Altura: 1,83 m

Médico: DRA. PATRICIA DANIELA OYAMA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 04-04-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 596,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 106,5 e 153,5 minutos. O tempo total de sono foi de 318,5 min, eficiência de 53,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,1%; estágio N2: 62,2%; estágio N3: 10,8%; sono REM: 23,9%. O índice de despertares foi de 10,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 26,4/hora, sendo 2 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 138 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 74%, permanecendo 3,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 63 - 89 bpm e NREM de 61 - 92 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. ligeiro aumento do número de despertares breves;
5. registro de ronco durante o sono.

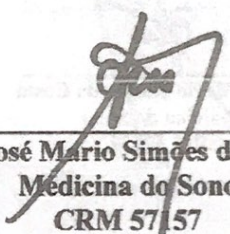
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 13,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

IDA
SIN
QU
ME

ME
E)
H
H
C
B
F
T
C

Nome: EUGENIO DANIEL FILHO

Data de Nascimento: 2-4-1954

IMC: 25,08

Sexo: Masculino

Data do exame: 27-02-2023

Peso: 84 kg

Altura: 1,83 m

Médico: DRA. PATRICIA DANIELA OYAMA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 27-02-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 568,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 126,0 e 96,5 minutos. O tempo total de sono foi de 300,0 min; eficiência de 52,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,3%; estágio N2: 62,5%; estágio N3: 10,3%; sono REM: 24,8%. O índice de despertares foi de 31,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 61,8/hora, sendo 57 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 98 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 71%, permanecendo 12,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 63 - 96 bpm e NREM de 62 - 96 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (8), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 61,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=71%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (21,2/hora);
8. presença de atividade em EMG de queixo;
9. registro de ronco durante o sono.

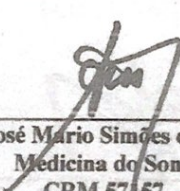
Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau acentuado associado a distúrbio de movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157